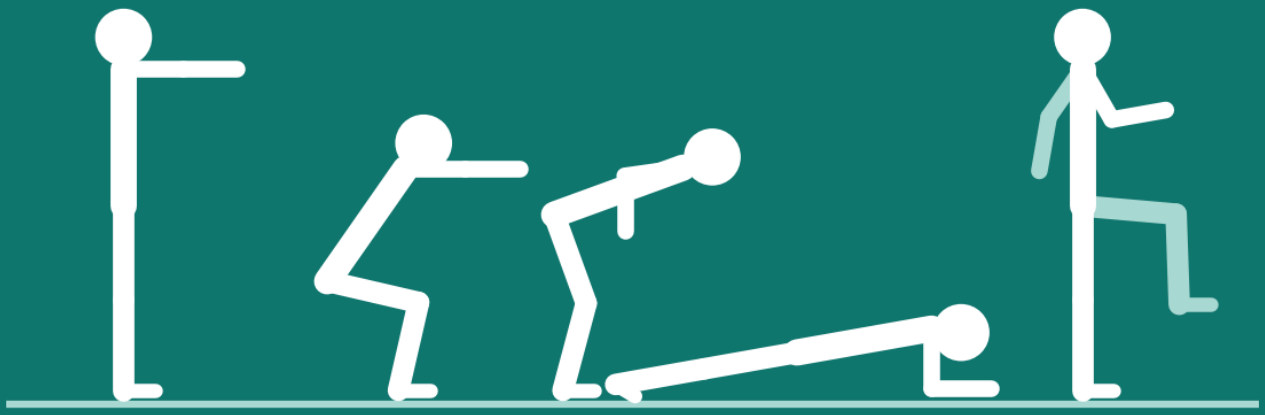
GUIA PRÁTICO

Emagrecer com saúde, sem depender do Ozempic



Alimentação · Suplementos · Treino de força em casa · Tai Chi · Sono · Hábitos

Preparado para **Nestor Araujo**



Ponto de partida: 112 kg e abdômen de 109 cm · **Meta:** 90 kg (−22 kg) · **Tratamento:** 4 meses de semaglutida (Ozempic), encerrando

O que você encontra neste guia

Parte	Conteúdo
1	Seu momento, plano em números (calorias, proteína), metas e cuidados com os remédios
2	Alimentação: prato, proteína, fibras, cardápios, seu suco, fome, restaurantes, compras
3	Suplementos e vitaminas: revisão dos que você já toma, evidências e o que evitar
4	Treino de força em casa: 7 exercícios ilustrados e plano de 12 semanas
5	Tai Chi e equilíbrio: 2 posturas ilustradas e rotina de 10 minutos
6	Sono (inclui ronco e apneia), estresse e comportamento
7	Acompanhamento, exames, sinais de alerta e checklist semanal

Elaborado em 07/11/2026. As informações são gerais e educativas.

Parte 1 · Seu momento e o que esperar

Leia primeiro

- Este guia é **educativo**. Você usa metformina, um inibidor de apetite e suplementos; por isso, **combine as mudanças com o médico que prescreveu** (endocrinologista ou nutrólogo) antes de parar, reduzir ou trocar qualquer medicamento.
- Se tiver doença no coração, rim, fígado, pressão alta, diabetes ou lesão articular, peça liberação médica antes de iniciar os treinos.
- Os números foram personalizados para homem, 59 anos e 1,79 m, mas ainda sem seus exames. Trate-os como **pontos de partida**.

O que acontece quando o Ozempic termina

A semaglutida reduz fome e aumenta saciedade enquanto você a usa. Ao parar, o efeito vai diminuindo ao longo de semanas e **o apetite tende a voltar**. No estudo de extensão do STEP 1 (Wilding et al., 2022), pessoas que interromperam a semaglutida sem manter um plano estruturado recuperaram cerca de dois terços do peso perdido em um ano. Isso não é falta de força de vontade: é biologia. A boa notícia é que **alimentação organizada, proteína alta, treino de força, sono e acompanhamento** reduzem bastante esse risco.

Seu histórico mostra algo útil: você chegou a 108 kg e voltou a 112 kg mesmo em tratamento. Causas comuns para isso, que o plano abaixo ataca:

- comer pouco e com **pouca proteína** (perde-se massa muscular e o gasto energético cai);
- **calorias líquidas** (sucos, batidas, bebidas) que enganam a saciedade;
- **pouco movimento** fora de 2 caminhadas semanais e nenhum treino de força;
- sono curto, estresse e uso de estimulantes (inibidor de apetite, cafeína), que bagunçam fome e descanso;
- oscilações de água (sal, ciclo hormonal, creatina, carboidrato) que não são gordura.

Metas realistas

Um ritmo sustentável costuma ficar entre **0,4 e 0,7 kg por semana** (cerca de 2 a 3 kg por mês). Para sair de 112 kg e chegar a 90 kg, isso significa **aproximadamente 8 a 13 meses**, com semanas de platô no caminho. Perder muito mais rápido costuma custar músculo, aumenta risco de pedra na vesícula e favorece o efeito sanfona.

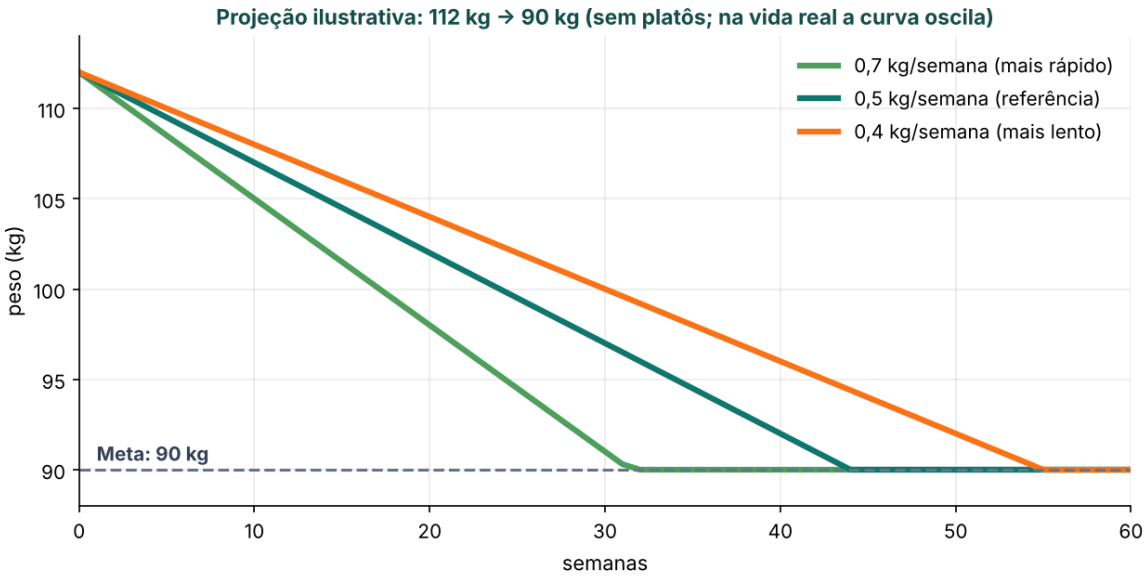


Figura 1. Projeção ilustrativa. A balança vai oscilar; olhe a tendência de 3 a 4 semanas.

Marco	Peso	Sinal de que está dando certo
Fase 1 (semanas 1–4)	−1 a −3 kg	Rotina de refeições estabelecida, 3 treinos por semana, sono mais regular
Fase 2 (meses 2–4)	−4 a −8 kg	Cintura diminuindo, mais força nos exercícios, menos beliscos
Fase 3 (meses 5–8)	−9 a −16 kg	Roupas folgadas, caminhadas mais longas sem cansaço
Fase 4 (até 13 meses)	−17 a −22 kg	Peso perto de 90 kg; começa a transição para manutenção

Cuidados com os medicamentos que você usa

Item	O que saber	O que fazer
Ozempic (semaglutida)	Você decidiu não renovar. O apetite volta gradualmente e o risco de reganho é real.	Informe o prescritor sobre a decisão e peça um plano de transição. Comece as estratégias de saciedade deste guia **antes** da última dose perder efeito.
Inibidor de apetite	Muitos são estimulantes: podem elevar pressão e frequência cardíaca, causar insônia, ansiedade e boca seca. Não deve ser combinado com termogênicos ou excesso de cafeína.	Confirme com o médico o nome, a dose e por quanto tempo usar. Tome pela manhã. Meça a pressão. Relate palpitações ou insônia.
Metformina	Pode reduzir a absorção de vitamina B12 e causar desconforto intestinal. Com perda de peso, a necessidade pode mudar.	Tome com as refeições. Dose B12 no exame. Não altere a dose sozinho; o médico ajusta conforme glicemia e HbA1c.
Suplementos e vitaminas	Alguns são úteis, outros só aumentam o custo ou interagem com remédios (ver Parte 3).	Leve a lista completa na próxima consulta.

Seu plano em números

Perfil usado: Nestor, homem, 59 anos, 1,79 m, 112 kg, abdômen de 109 cm, sono de 6 a 7 horas, caminhadas 2 vezes por semana, sem treino de força. Os valores são **estimativas** (fórmula de Mifflin-St Jeor) para começar; revise com nutricionista e reajuste a cada 5 kg perdidos.

Indicador	Estimativa	Comentário
IMC atual	≈ 35 kg/m²	Com 90 kg: ≈ 28 kg/m². A redução de risco já é grande no caminho
Taxa basal	≈ 1.950 kcal/dia	Energia que o corpo gasta em repouso
Gasto total	≈ 2.500 a 2.700 kcal/dia	Com mais treino e passos, tende ao topo da faixa
Meta de calorias (início)	≈ 2.000 a 2.200 kcal/dia	Déficit de 400 a 600 kcal. Não ir abaixo de ≈ 1.800 sem acompanhamento
Proteína	110 a 140 g/dia	30 a 40 g por refeição principal; aos 59 anos, doses maiores por refeição protegem melhor o músculo
Gorduras	≈ 55 a 70 g/dia	Azeite, abacate, castanhas, peixes
Carboidratos	≈ 220 a 260 g/dia	Integrais, feijões, frutas, tubérculos
Fibras	30 a 35 g/dia	Aumente aos poucos, com água
Água	≈ 3 L/dia	Mantenha, salvo orientação médica em contrário
Abdômen/cintura (no umbigo)	atual: 109 cm meta: abaixo de 94 cm	Redução de ≈ 15 cm. Meça a cada 2 semanas, sempre no mesmo ponto e ao final da expiração
Sono	7 a 8 h/noite	Hoje: 6 a 7 h. Veja também a seção de apneia na Parte 6

Distribuição de calorias ao longo do dia (modelo de ≈ 2.100 kcal)

Refeição	Calorias aprox.	Proteína aprox.
Café da manhã	400–450 kcal	25–35 g
Lanche da manhã	150–200 kcal	10–15 g
Almoço	600–700 kcal	35–45 g
Lanche da tarde	200–250 kcal	20–25 g
Jantar	450–550 kcal	30–40 g

Atenção por idade e perfil de risco

- **Avaliação médica antes de intensificar o treino:** pressão, ECG e, se o médico indicar, teste de esforço. Peso maior, 59 anos, sedentarismo e inibidor de apetite (estimulante) pedem essa checagem.
- **Força é prioridade:** nessa idade, perder músculo e osso é um risco real em dietas. Os 3 treinos semanais da Parte 4 são parte central do plano.
- **Exames:** vitamina D, B12, glicemia/HbA1c, lipídios, PSA conforme orientação urológica, função renal e hepática.

Parte 2 · Alimentação para emagrecer e manter

O objetivo é criar um **déficit calórico moderado** (em geral, 400 a 600 kcal abaixo do que você gasta por dia) mantendo **proteína alta, fibras e refeições regulares**. Contar calorias é opcional: o método do prato abaixo costuma bastar. Um nutricionista pode calcular suas necessidades exatas com altura, idade, sexo e composição corporal.

1. Método do prato

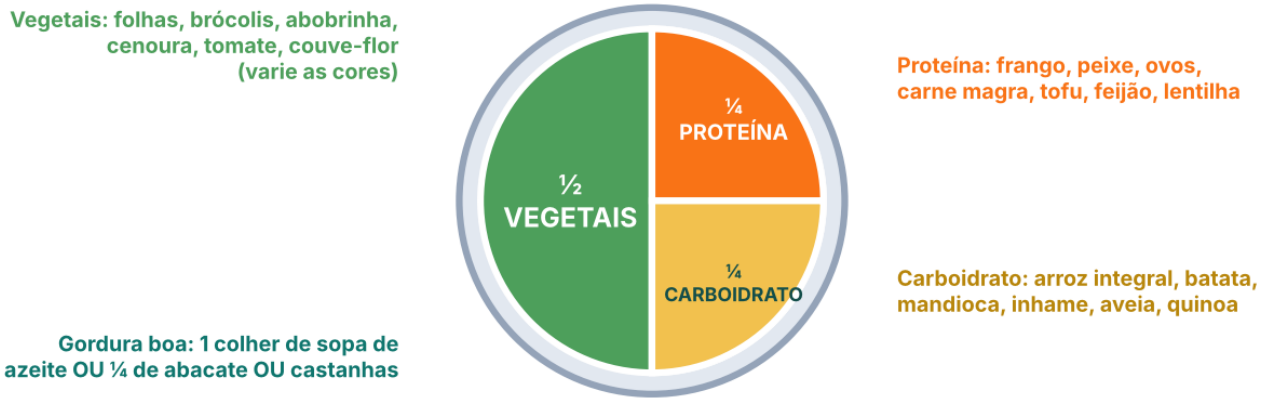


Figura 2. Monte o almoço e o jantar assim. Use um prato raso (cerca de 24 cm) e sirva uma vez.

2. Proteína: a prioridade número 1

Com a queda do apetite pela medicação, é fácil comer pouca proteína, e isso aumenta a perda de músculo. Uma meta prática para quem treina força e está em déficit é de **1,2 a 1,6 g por kg** de peso (usando um peso entre o atual e a meta, isso dá cerca de **100 a 140 g por dia**), dividida em **25 a 40 g por refeição**. Pessoas com doença renal devem validar essa meta com o médico.

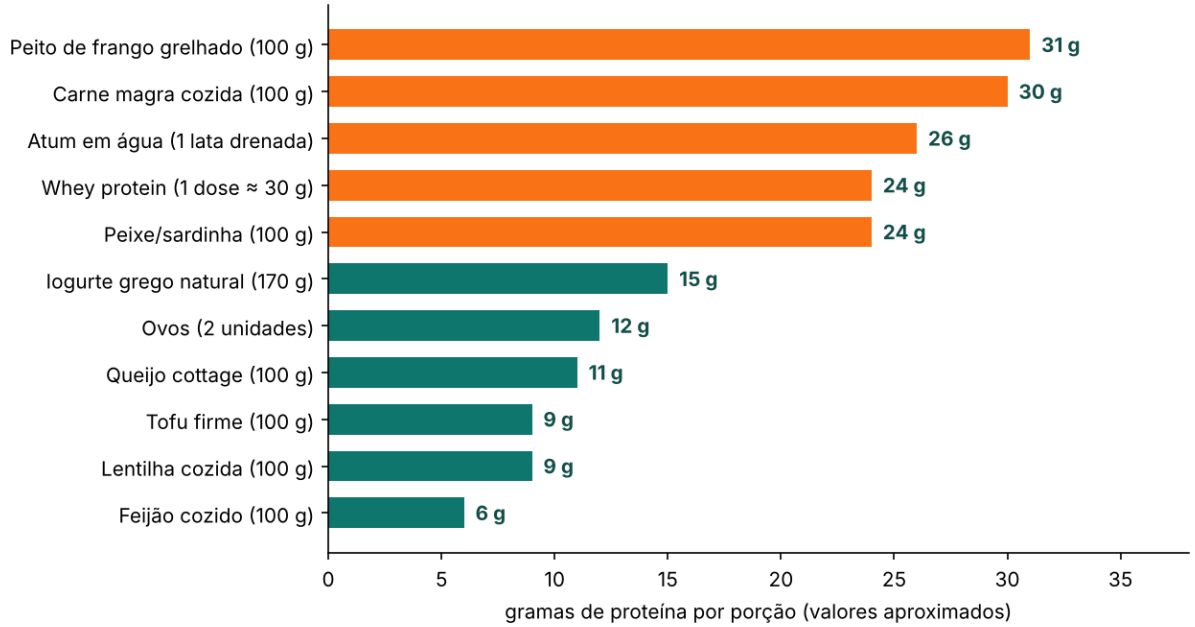


Figura 3. Proteína por porção (valores aproximados; confira o rótulo).

Como bater a meta sem esforço

- Comece cada refeição pela proteína e pela salada; deixe o carboidrato por último.
- Café da manhã com 25–30 g de proteína (ovos, iogurte grego, whey, queijo cottage).
- Tenha sempre prontos: ovos cozidos, frango desfiado, atum, iogurte grego, feijão cozido.

3. Fibras, líquidos e saciedade

- **Fibras: 25 a 35 g por dia**: feijões, lentilha, grão-de-bico, aveia, chia, linhaça, frutas com casca, verduras, legumes e grãos integrais. Aumente aos poucos e beba água junto.
- **Água:** seus 3 litros estão adequados para a maioria das pessoas. Ajuste se houver doença cardíaca ou renal. Um copo antes das refeições ajuda a controlar a porção.
- **Volume:** sopas de legumes, saladas grandes e legumes cozidos preenchem o estômago com poucas calorias.
- **Mastigação lenta:** a refeição deve durar pelo menos 15 a 20 minutos. Largue o talher entre as garfadas.
- **Bebidas:** água, água com gás, café sem açúcar e chás sem açúcar. Evite refrigerantes, sucos de caixinha e bebidas açucaradas.

4. Seu suco da manhã: como melhorar

A mistura que você descreveu (legumes, limão, maçã, abacate, chia, semente de abóbora, vinagre de maçã e whey) tem proteína, fibra e gorduras boas, o que é ótimo. O ponto de atenção é a **densidade calórica**: dependendo das medidas, pode chegar a 400–500 kcal, e líquido sacia menos do que comida mastigada.

Ingrediente	Sugestão de medida	Observação
Abacate	¼ a ½ unidade pequena	Rico em gordura boa, mas calórico
Chia + semente de abóbora	1 colher de sopa de cada	Fibra e minerais; não exagerar
Maçã	1 unidade com casca	Mantenha a fibra: não coe o suco
Whey	1 dose (25–30 g de proteína)	Cobre quase um quarto da meta do dia
Legumes e folhas	1 a 2 xícaras (couve, pepino, cenoura)	Volume com poucas calorias
Vinagre de maçã	Opcional, 1 colher de chá diluída	Evidência fraca para emagrecer; pode irritar esôfago e esmalte dental

Dica: tome o suco devagar, em 15 a 20 minutos, e acompanhe de algo mastigável (1 ovo cozido ou 1 fatia de pão integral) para aumentar a saciedade.

5. Como organizar o dia sem o efeito do remédio

Comer apenas duas refeições grandes funciona enquanto o remédio segura a fome, mas tende a gerar **fome intensa e exageros à noite** quando o efeito passa. O ideal agora é **3 refeições principais + 1 ou 2 lanches com proteína**, em horários regulares, sem ficar mais de 4 a 5 horas sem comer.

Horário	Modelo A	Modelo B	Modelo C
Café da manhã (7–9 h)	Seu suco ajustado + 1 ovo cozido	2 ovos mexidos + 1 fatia de pão integral + mamão	Iogurte grego + aveia + frutas vermelhas + chia
Lanche (10–10:30 h)	1 fruta + 10 castanhas	Queijo cottage + tomate	Iogurte natural + 1 colher de linhaça

Horário	Modelo A	Modelo B	Modelo C
Almoço (12–13 h)	Prato: salada + frango grelhado + feijão + ¼ prato de arroz integral + 1 col. sopa de azeite	Prato: legumes assados + peixe + batata-doce + folhas	Prato: salada + carne magra + lentilha + mandioca
Lanche (15:30–16 h)	Whey com água/leite + 1 banana pequena	Ovo cozido + 1 fruta	Atum com tomate e torrada integral
Jantar (19–20 h)	Sopa de legumes com frango desfiado	Omelete de legumes + salada	Salada completa com grão-de-bico e atum
Ceia (opcional)	Chá de camomila	Iogurte natural	Chá de erva-cidreira

Proteína estimada nesses modelos: de 100 a 130 g por dia, dependendo das porções. Ajuste as quantidades conforme fome, peso e orientação do nutricionista.

6. Lista de compras base

Proteínas	Carboidratos e fibras	Vegetais e frutas	Gorduras e extras
Ovos, peito de frango, carne magra, peixes, atum e sardinha em lata, iogurte grego natural, queijo cottage, tofu, whey	Feijão, lentilha, grão-de-bico, aveia, arroz integral, batata-doce, mandioca, pão integral, chia, linhaça	Folhas variadas, brócolis, couve-flor, abobrinha, cenoura, tomate, pepino; maçã, mamão, frutas vermelhas, laranja, banana	Azeite extravirgem, abacate, castanhas, sementes, ervas, alho, limão, especiarias, café e chás

7. O que limitar

- Ultraprocessados: biscoitos, salgadinhos, embutidos, macarrão instantâneo, refeições congeladas prontas, fast food.
- Açúcar adicionado: refrigerantes, sucos de caixinha, achocolatados, doces. Cuidado com "fit" e "zero" que ainda são calóricos e pouco saciantes.
- **Álcool:** tem 7 kcal por grama, reduz o controle da fome e piora o sono. Se beber, que seja ocasional e em pequena quantidade.
- **Kombucha:** pode entrar, mas escolha versões **sem açúcar adicionado** (confira o rótulo), em porção de 150 a 200 ml, de preferência até o início da tarde (tem cafeína do chá). Há pouco álcool residual, e a acidez agride o esmalte, então enxágue a boca com água depois. A evidência de que ajude a emagrecer é fraca.
- Frituras e molhos cremosos. Prefira grelhar, assar ou cozinhar.
- Chás "detox" e laxantes (sene, cáscara): causam perda de água e desequilíbrio de eletrólitos, não de gordura. Seu chá diário é bem-vindo se for sem açúcar.

8. Estratégias para a fome que volta

- **Regra do 10:** bateu vontade fora de hora? Beba água, espere 10 minutos e se distraia; se continuar, coma um lanche planejado com proteína.
- **Proteína + fibra** em toda refeição e lanche (a combinação que mais sacia).
- Não deixe comida de gatilho à vista ou em estoque em casa. Compre porções individuais.
- **Regra 80/20:** 80% das escolhas seguem o plano; 20% têm flexibilidade. Perdeu uma refeição? Retome na próxima, sem compensar com jejum.
- Evite pular refeições e evite "recompensar" o treino com comida.
- Identifique o tipo de fome: física (estômago vazio, qualquer comida serve) ou emocional (vontade específica, surge com estresse, tédio, cansaço).

- Se houver episódios de comer grande quantidade com perda de controle, procure psicólogo ou médico: é tratável.

9. Comendo fora e em festas

- Coma algo com proteína antes de sair para não chegar com muita fome.
- Escolha grelhados, saladas, legumes e feijão; peça molhos à parte.
- Divida sobremesa, escolha fruta ou 1 porção pequena.
- No rodízio ou buffet: prato de salada primeiro, depois proteínas; um único prato principal.

10. Lendo rótulos

- Lista de ingredientes curta é melhor. Se açúcar, xarope, maltodextrina ou gordura hidrogenada estão entre os primeiros itens, evite.
- Compare por 100 g, não por porção. Procure mais proteína e fibra, menos açúcar e sódio.
- "Light", "fit", "zero" e "integral" são termos de marketing: confira sempre a tabela nutricional.

Parte 3 · Suplementos e vitaminas

Suplementos **complementam** a alimentação e não substituem comida nem treino. Priorize os com boa evidência, e **valide dose e combinação com seu médico**, principalmente por causa da metformina e do inibidor de apetite. Exames que orientam a escolha: vitamina D, vitamina B12, ferritina, hemograma, creatinina, TSH, glicemia, HbA1c, perfil lipídico e enzimas do fígado.

Suplemento	Para quê	Evidência	Dose usual (adulto saudável)	Cuidados
Whey protein	Ajudar a bater a meta de proteína	Alta	20–30 g por dose; 1 a 2 doses/dia se necessário	Intolerância à lactose (prefira isolado ou vegetal); doença renal: consultar
Creatina monoidratada	Ganho de força e massa magra	Alta	3–5 g por dia, todos os dias	Retém 1–2 kg de água nas primeiras semanas (não é gordura). Beba água. Rim: consultar
Vitamina D3	Saúde óssea, imunidade; muitas pessoas têm nível baixo	Moderada (se deficiência)	Conforme exame (25-OH vitamina D)	Excesso é nocivo; dosar antes e depois
Vitamina B12	Metformina pode reduzir níveis	Alta se baixa	Conforme exame de B12	Dosar a cada 6–12 meses
Ômega-3 (EPA+DHA)	Se você come pouco peixe	Moderada	1–2 g de EPA+DHA por dia	Atenção com anticoagulantes
Magnésio (glicinato ou citrato)	Cãibras, sono	Moderada	200–400 mg elementar, à noite	Pode causar diarreia; rim: consultar
Psyllium (fibra)	Saciedade, intestino, glicemia	Moderada	5 g, 1–2 vezes/dia, com 1 copo grande de água	Comece devagar; separe de remédios por 1–2 horas
Cafeína	Disposição e desempenho	Moderada	Até 400 mg/dia no total	**Cuidado com o inibidor de apetite**: somar estimulantes eleva pressão e piora sono. Evite após 14 h
Multivitamínico	Cobrir lacunas se a dieta for restrita	Baixa/moderada	1 por dia	Útil só se houver restrição alimentar

Seus suplementos atuais: revisão

Esta é uma análise geral. Leve a lista completa, com doses, ao médico ou nutricionista para validar.

Suplemento	Avaliação	Pontos de atenção
Cromo	Evidência fraca para emagrecer ou controlar glicemia	Pode somar efeito à metformina e baixar a glicemia. Em geral, dispensável; discuta com o médico antes de continuar
Magnésio	Útil, sobretudo à noite	Prefira glicinato ou citrato; pode soltar o intestino. Atenção se houver doença renal
Zinco	Ok em dose habitual	Doses altas por muito tempo (acima de 40 mg/dia) podem causar deficiência de cobre. Confirme a dose do seu produto
NAC (N-acetilcisteína)	Sem benefício comprovado para emagrecimento	Pode causar náusea ou desconforto gástrico. Continue só se houver indicação específica do médico
Vitamina D	Útil se o nível estiver baixo	Dose conforme exame de 25-OH vitamina D; repita o exame após 3 meses
Complexo B	Útil: a metformina reduz a B12	Cheque a dose de B6 (uso prolongado em doses muito altas pode causar neuropatia). Dose a B12 no sangue
Vitamina C	Ok em doses moderadas	Doses muito altas podem causar desconforto intestinal e, em predispostos, pedra nos rins. Mantenha até cerca de 500 mg a 1 g/dia
Espirulina	Proteína em quantidade pequena e evidência fraca para peso	Escolha marca com certificação de qualidade (risco de contaminação). Não substitui a meta de proteína. Cuidado com imunossupressores

Resumo: o que está bem alinhado ao seu perfil é vitamina D, complexo B (pela metformina) e magnésio. Revise cromo, NAC e o total de zinco e vitamina C com o profissional. Não é preciso tomar tudo todos os dias; menos itens, com propósito claro, costuma ser melhor. Acrescente a creatina (3 a 5 g/dia) quando começar o treino de força, se o médico concordar e seus rins estiverem saudáveis.

Evite

- **Termogênicos e queimadores de gordura:** somam estimulantes ao seu inibidor de apetite e podem causar taquicardia e pressão alta.
- Chás e cápsulas "detox", diuréticos, laxantes e produtos com sene.
- Garcínia, vinagre em cápsula e produtos "naturais" sem comprovação.
- Anabolizantes e SARMs: riscos graves à saúde e ilegais sem prescrição.

Parte 4 · Treino de força em casa

O treino de força é a ferramenta mais importante para **proteger o músculo** enquanto você emagrece, manter o metabolismo e melhorar glicemia, postura e humor. O plano abaixo exige **pouco material** e é de baixo impacto para as articulações. Comece fácil e progrida devagar.

Materiais

- Cadeira firme (sem rodinhas) e uma parede.
- Sofá, bancada ou mesa estáveis para a flexão inclinada.
- Mochila com livros (3 a 8 kg) e 2 garrafas PET de 2 litros com água (2 kg cada).
- Tapete ou colchonete e uma toalha.
- Opcional: faixa elástica.

Regras de ouro

- **3 treinos por semana**, em dias alternados (A, B, A... na semana seguinte B, A, B).
- **Esforço moderado:** termine cada série com 2 a 3 repetições "sobrando" (nível 7 de 10).
- **Descanso** de 60 a 90 segundos entre séries. Movimento controlado: 2 segundos para subir, 2 a 3 para descer.
- **Respire:** solte o ar no esforço. Não prenda a respiração.
- Desconforto muscular é normal; **dor aguda em articulação, tontura ou dor no peito** são motivos para parar.
- Evite saltos e corrida nas primeiras 8 a 12 semanas para poupar joelhos e tornozelos. Use calçado com bom amortecimento.
- Progrida primeiro nas **repetições**, depois na **carga**. Anote tudo.

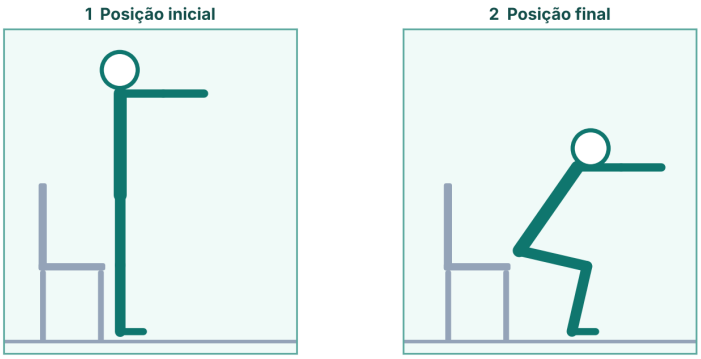
Aquecimento (5 minutos)

- Marcha no lugar: 1 minuto.
- Círculos de ombros: 10 para trás e 10 para frente.
- Rotação de quadril: 10 para cada lado.
- Agachamento parcial: 10 repetições.
- Gato-camelo (4 apoios): 8 repetições.

Treinos A e B

Treino A	Treino B
1. Agachamento na cadeira 2. Flexão inclinada 3. Ponte de glúteos 4. Prancha	1. Afundo com apoio 2. Remada com mochila ou garrafas 3. Bird-dog 4. Tai Chi: posição do cavaleiro

1. Agachamento na cadeira



Séries × repetições: 2–3 × 8–12 · **Músculos:** Quadríceps, glúteos, core

Como fazer

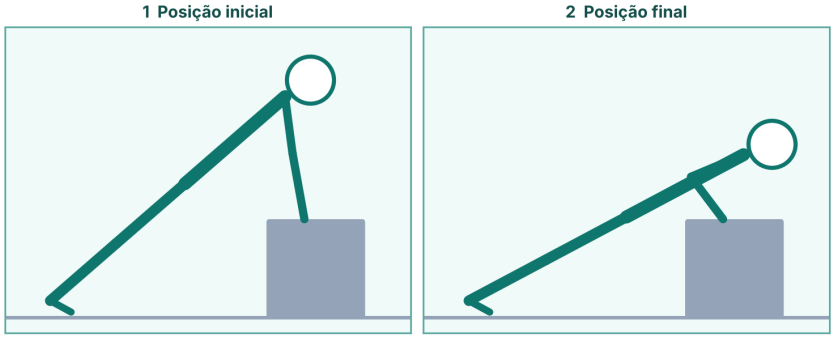
- Fique de pé de costas para a cadeira, pés na largura dos ombros, pontas dos pés levemente abertas.
- Empurre o quadril para trás e flexione os joelhos como se fosse sentar. Mantenha o peito aberto e os calcanhares no chão.
- Toque de leve na cadeira (sem relaxar o corpo) e suba empurrando o chão com os pés.

Erro comum: Joelhos entrando para dentro; calcanhares saindo do chão; tronco caindo para frente.

Mais fácil: Aumentar a altura da cadeira (almofada) ou apoiar as mãos em uma mesa.

Mais difícil: Segurar a mochila junto ao peito; pausa de 2 segundos embaixo; usar uma cadeira mais baixa.

2. Flexão inclinada (mãos no sofá ou bancada)



Séries × repetições: 2–3 × 6–12 · **Músculos:** Peito, ombros, tríceps, core

Como fazer

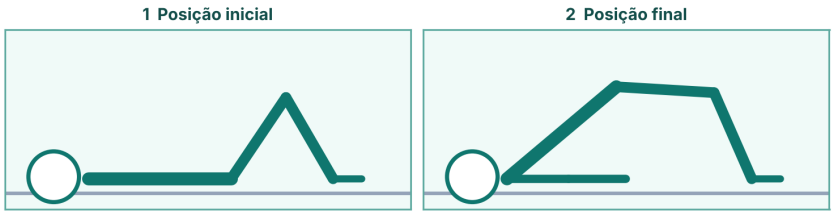
- Apoie as mãos na borda de uma superfície firme, na largura dos ombros. Corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares.
- Dobre os cotovelos (a cerca de 45° do tronco) e leve o peito até a borda.
- Empurre de volta sem deixar o quadril cair ou subir.

Erro comum: Lombar afundando; cotovelos abertos a 90°; apoio instável (use algo que não escorregue).

Mais fácil: Fazer na parede ou usar uma superfície mais alta.

Mais difícil: Usar uma superfície mais baixa (degrau), depois flexão com joelhos no chão.

3. Ponte de glúteos



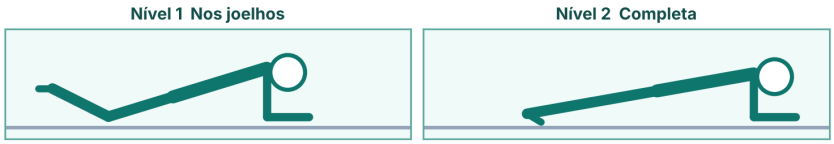
Séries × repetições: 2–3 × 10–15 · **Músculos:** Glúteos, posteriores de coxa, lombar

Como fazer

- Deite de costas, joelhos dobrados, pés no chão na largura do quadril, braços ao lado do corpo.
- Aperte os glúteos e suba o quadril até formar uma linha do ombro ao joelho. Segure 1 a 2 segundos.
- Desça devagar, sem encostar totalmente o quadril no chão entre as repetições.

Erro comum: Arquear demais a lombar; empurrar com a ponta dos pés; subir rápido demais.
Mais fácil: Reduzir a altura da subida.
Mais difícil: Colocar a mochila sobre o quadril ou fazer a ponte com uma perna só.

4. Prancha (nos joelhos e completa)



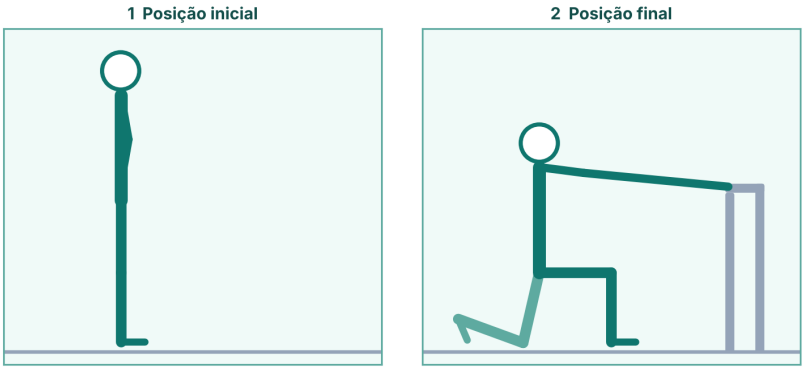
Séries × repetições: 3 × 15–40 segundos · **Músculos:** Abdômen, glúteos, ombros

Como fazer

- Apoie os antebraços no chão, cotovelos sob os ombros.
- Mantenha uma linha reta (nível 1: da cabeça aos joelhos; nível 2: da cabeça aos pés). Contraia abdômen e glúteos.
- Respire normalmente e olhe para o chão, pescoço neutro.

Erro comum: Quadril caindo ou muito alto; prender a respiração; pescoço projetado.
Mais fácil: Começar com 10 a 15 segundos nos joelhos.
Mais difícil: Chegar a 60 segundos na prancha completa; depois elevar um pé alternadamente.

5. Afundo com apoio



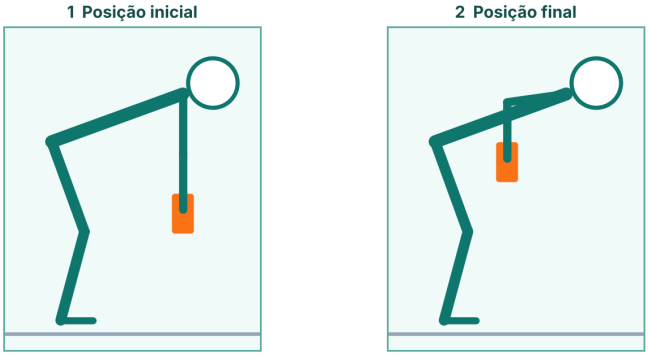
Séries × repetições: 2 × 6–10 por perna · **Músculos:** Coxas, glúteos, equilíbrio

Como fazer

- Segure no encosto de uma cadeira firme (ou na parede). Dê um passo largo à frente, com a outra perna atrás e o calcanhar elevado.
- Dobre os dois joelhos até o de trás se aproximar do chão. O joelho da frente fica alinhado ao pé.
- Suba empurrando o calcanhar da frente. Faça todas as repetições de um lado e troque.

Erro comum: Passo curto demais; joelho da frente caindo para dentro; tronco inclinado.
Mais fácil: Reduzir a amplitude e manter as duas mãos no apoio.
Mais difícil: Soltar o apoio, segurar garrafas ou mochila; depois fazer afundo caminhando.

6. Remada com mochila ou garrafas



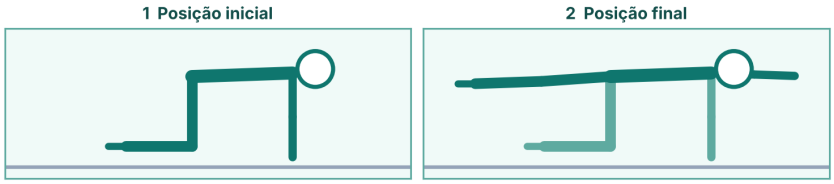
Séries × repetições: 2–3 × 10–12 · **Músculos:** Costas, ombros posteriores, bíceps

Como fazer

- Joelhos levemente dobrados, quadril para trás e tronco inclinado, costas retas. Segure a mochila ou garrafas com os braços estendidos.
- Puxe os cotovelos em direção ao quadril, aproximando as escápulas.
- Desça controlando a carga.

Erro comum: Arredondar a coluna; balançar o corpo para ajudar a puxar; ombros subindo.
Mais fácil: Apoiar uma mão na cadeira e remar com um braço de cada vez.
Mais difícil: Aumentar a carga (mochila mais pesada) ou fazer pausa de 2 segundos no topo.

7. Bird-dog (cachorro e pássaro)



Séries × repetições: 2 × 8 por lado · **Músculos:** Core, lombar, glúteos, equilíbrio

Como fazer

- Fique de quatro apoios: mãos sob os ombros e joelhos sob o quadril, coluna neutra.
- Estenda um braço à frente e a perna do lado **oposto** para trás, sem girar o tronco. Segure 2 a 3 segundos.
- Retorne com controle e troque de lado.

Erro comum: Girar o quadril; arquear a lombar; mover-se rápido demais.
Mais fácil: Estender só a perna ou só o braço.
Mais difícil: Aproximar cotovelo e joelho embaixo do corpo antes de estender de novo.

Progressão em 12 semanas

Semanas	Treino de força	Prancha	Caminhada
1–2	2 séries × 8–10 repetições, esforço leve a moderado	15–20 s (joelhos)	3× por semana, 25–30 min em ritmo confortável
3–4	2–3 séries × 10–12	20–30 s	4× por semana, 30–35 min
5–8	3 séries × 10–12; adicionar carga (mochila 3–5 kg)	30–45 s	4–5× por semana, 35–45 min; inserir 4 blocos de 1 min mais rápido
9–12	3 séries × 12–15 ou carga maior; afundo sem apoio	45–60 s	5× por semana, 45–60 min; 6 blocos de 1 min rápido

Semana-modelo

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Treino A + alongar	Caminhada 30–45 min	Treino B + alongar	Caminhada 30–45 min	Treino A + alongar	Caminhada longa + Tai Chi	Descanso ativo: passeio, mobilidade

Passos diários

Além das caminhadas, procure aumentar os passos no dia a dia (escadas, ligações em pé, estacionar mais longe). Uma meta progressiva de **7.000 a 10.000 passos por dia** ajuda bastante no gasto de energia e na saúde cardiovascular.

Alongamento final (3 a 5 minutos)

- Panturrilhas na parede: 30 s por perna.
- Frente das coxas em pé, apoiado: 30 s por perna.

- Posteriores de coxa sentado: 30 s por perna.
- Peitoral no batente da porta: 30 s.
- Postura da criança: 30 a 60 s.

Parte 5 · Tai Chi, equilíbrio e mobilidade

O Tai Chi combina movimentos lentos, respiração e equilíbrio. Não queima muita gordura por si só, mas **melhora equilíbrio, mobilidade, postura e controle do estresse**, e ajuda a manter a regularidade, o que importa muito em um processo longo. Funciona como complemento ao treino de força e às caminhadas.

8. Tai Chi: posição do cavaleiro e "abraçar a bola"



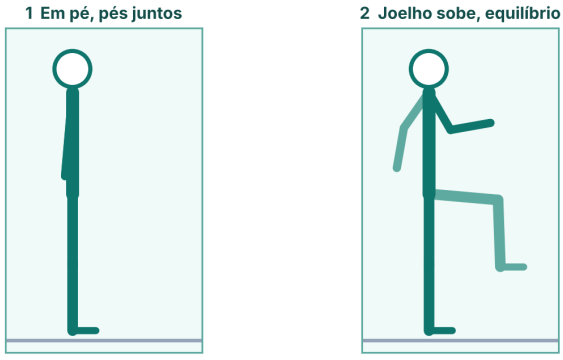
Séries × repetições: 3 × 30–60 segundos · **Músculos:** Pernas, quadril, postura, respiração

Como fazer

- Afaste os pés um pouco mais do que a largura dos ombros, pontas levemente abertas.
- Dobre os joelhos mantendo-os alinhados com os pés, coluna alta e ombros relaxados.
- Leve as mãos à frente do peito como se abraçasse uma bola. Inspire ao abrir os braços e expire ao aproximar. Respire pelo nariz, devagar.

Erro comum: Joelhos para dentro; tronco inclinado; ombros tensos; prender a respiração.
Mais fácil: Dobrar menos os joelhos e reduzir o tempo.
Mais difícil: Descer mais e aumentar o tempo para 1 a 2 minutos.

9. Tai Chi: galo dourado (equilíbrio em uma perna)



Séries × repetições: 3 × 5–15 s por lado · **Músculos:** Equilíbrio, tornozelo, core

Como fazer

- Fique ao lado de uma parede ou cadeira para apoiar a mão se precisar. Olhe para um ponto fixo à frente.
- Transfira o peso para uma perna, mantendo o joelho levemente solto, e eleve o outro joelho devagar até a altura do quadril.
- Eleve a mão do mesmo lado do joelho à frente do peito. Respire e volte com controle.

Erro comum: Segurar a respiração; olhar para o chão; inclinar o tronco para o lado.
Mais fácil: Manter a ponta do pé no chão ou apoiar uma mão na parede.
Mais difícil: Fechar os olhos por poucos segundos (com apoio por perto) ou subir mais devagar.

Rotina de 10 minutos (Tai Chi ou Qigong leve)

Faça de preferência nos dias sem treino de força, ou à noite como ritual de desaceleração. Para aprender com qualidade, procure vídeos de Tai Chi para iniciantes de instrutores certificados ou uma aula presencial.

- **1 min:** em pé, pés paralelos, respiração abdominal lenta (inspira 4 s, expira 6 s).
- **2 min:** balanço suave do peso entre as pernas, ombros soltos.
- **3 min:** cavaleiro com "abraçar a bola", abrir e fechar os braços em sincronia com a respiração.
- **2 min:** galo dourado, 3 repetições em cada lado, com apoio.
- **2 min:** mãos descendo lentamente do peito ao abdômen, respiração tranquila.

Parte 6 · Sono, estresse e comportamento

Dormir mal aumenta o apetite (sobe a grelina, o hormônio da fome, e cai a leptina, o da saciedade), aumenta a vontade de comer ultraprocessados e reduz a proporção de gordura perdida em uma dieta. Para a maioria dos adultos, o ideal é **7 a 9 horas** de sono por noite.



Figura 4. Exemplo de rotina. Ajuste os horários à sua realidade, mas mantenha-os constantes, inclusive nos fins de semana.

Dicas fundamentais de sono

- **Horário fixo** para dormir e acordar (variação máxima de 1 hora).
- **Luz do sol** nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar ajusta o relógio biológico.
- **Cafeína até 14 h.** Chá preto, verde, mate e café têm cafeína. À noite, camomila, erva-cidreira ou capim-limão. Lembre que o inibidor de apetite também estimula: tome pela manhã e relate insônia ao médico.
- **Jantar 2 a 3 horas antes de deitar**, leve. Evite álcool, que fragmenta o sono.
- **Telas:** reduza 1 hora antes de dormir. Luz baixa e quente em casa à noite.
- **Quarto escuro, silencioso e fresco** (entre 18 e 22 °C). A cama é para dormir.
- **Ritual de 30 a 60 minutos:** banho morno, alongamento, leitura leve, respiração lenta.
- Evite treino intenso nas 2 a 3 horas antes de dormir. Sonecas, se necessárias, de até 20 a 30 min antes das 15 h.
- **Atenção a ronco alto, pausas respiratórias, boca seca ao acordar e sonolência diurna:** podem indicar **apneia do sono**, mais comum com excesso de peso. Vale investigar; tratar melhora fome, humor e peso.

Ronco intenso e provável apneia do sono

Você relata ronco intenso, provável apneia e um aparelho bucal que reduz pouco o problema. Pelo seu perfil (homem, 59 anos, IMC 35), isso merece **investigação formal**, e não apenas ajuste do aparelho. A apneia não tratada fragmenta o sono, aumenta a fome e a vontade de comer ultraprocessados, favorece o ganho de peso e eleva o risco de hipertensão, arritmias e problemas cardiovasculares. Também pode piorar a resposta ao inibidor de apetite, um estimulante.

- **Marque consulta com médico do sono** (ou otorrino/pneumologista com experiência) e faça uma **polissonografia** (de laboratório ou domiciliar, conforme indicação). Ela mostra se a apneia é leve, moderada ou grave.
- **Aparelho bucal (de avanço mandibular):** costuma funcionar melhor em apneia leve a moderada e precisa de ajuste feito por **dentista do sono**. Se ele reduz pouco o ronco, pode estar mal regulado ou o caso pode pedir outro tratamento.

- **CPAP** é o tratamento padrão em apneia moderada a grave. Muita gente se adapta melhor com ajuda de máscara adequada e acompanhamento. Só o médico define o que é indicado.
- **Perder peso ajuda de verdade:** reduzir cerca de 10% do peso melhora de forma importante a apneia em muitas pessoas. O emagrecimento e o tratamento se reforçam.
- **Medidas de apoio:** dormir de lado (evite de barriga para cima), elevar um pouco a cabeceira, evitar álcool e sedativos à noite, jantar leve e cedo, tratar nariz entupido.
- **Higiene do aparelho:** limpe-o todos os dias com escova macia e sabão neutro, deixe secar e guarde em estojo. Seu hábito de limpar a língua é ótimo e ajuda a manter a boca saudável.
- **Atenção ao dirigir:** se tiver sonolência durante o dia ou cochilos involuntários, evite dirigir cansado e procure atendimento rapidamente.

Sobre suas 6 a 7 horas de sono

Mesmo com a apneia tratada, tente **7 a 8 horas** na cama. Antecipe o horário de dormir em 15 minutos a cada 3 ou 4 dias até chegar ao objetivo, e mantenha o horário de acordar.

Estresse e emoções

- Reserve 5 a 10 minutos por dia para respirar, alongar ou caminhar sem celular.
- Use a "pausa de 10 minutos" antes de comer por impulso: pergunte o que você está sentindo.
- Combine metas por **comportamento** ("caminhar 3 vezes"), não só pelo número da balança.
- Conte com apoio: família, amigos, grupo de treino. Considere acompanhamento psicológico se a comida for sua principal forma de lidar com emoções.
- Celebre conquistas que não são de peso: força, energia, sono, cintura, exames.

Parte 7 · Acompanhamento, exames e segurança

Como medir o progresso

- **Peso:** 1 vez por semana, de manhã, após ir ao banheiro, sem roupa. Observe a média das últimas 3 a 4 semanas.
- **Cintura:** meça na altura do umbigo a cada 2 semanas. Quadril e coxa uma vez por mês.
- **Fotos** mensais (mesma luz e posição) e como as roupas ficam.
- **Desempenho:** repetições, carga, tempo de prancha, tempo de caminhada.
- **Qualidade de vida:** sono, energia, humor, fome.

Se o peso estagnar por 3 semanas

- Revise porções, bebidas calóricas, beliscos e fins de semana.
- Confira proteína, sono e passos diários.
- Lembre que ganho de força, creatina e ciclo hormonal podem esconder perda de gordura; compare a cintura.
- Se continuar, marque consulta: o plano pode precisar de ajustes.

Exames e acompanhamento sugeridos

Quando	O que
Antes de começar (se não tiver recentes)	Glicemia de jejum, HbA1c, perfil lipídico, TGO/TGP, creatinina, TSH, vitamina D, vitamina B12, ferritina, hemograma; pressão arterial
A cada 3 meses	Peso, cintura, pressão, glicemia/HbA1c, revisão das medicações com o médico
A cada 6 meses	Vitamina D, B12, perfil lipídico, função do fígado e rins
Equipe ideal	Médico (endocrinologista ou nutrólogo), nutricionista, educador físico, psicólogo se necessário

Procure atendimento médico se

- Dor no peito, falta de ar, palpitações, desmaio ou tontura forte, principalmente com o inibidor de apetite.
- Dor forte e persistente na parte superior do abdômen, vômitos que não passam, olhos ou pele amarelados.
- Perda de peso acima de 1 kg por semana por várias semanas, fraqueza intensa ou queda de cabelo importante.
- Glicemia muito alta ou muito baixa, sede excessiva, urina em grande quantidade.
- Tristeza profunda, insônia grave, compulsão alimentar ou pensamentos de se machucar.

Checklist semanal

Copie ou imprima. Marque 1 a cada dia em que cumprir.

Hábito	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
3 refeições + lanches planejados							
Proteína em todas as refeições							
Salada/legumes no almoço e jantar							
3 L de água							
Treino de força ou caminhada							
Tai Chi ou alongamento (10 min)							
Sono de 7 a 9 horas							
Sem bebida açucarada ou álcool							

Resumo em 10 pontos

- Meta realista: 0,4 a 0,7 kg por semana, com platôs.
- Fale com o médico sobre a transição do Ozempic, a metformina e o inibidor de apetite.
- 3 refeições + 1 a 2 lanches com proteína; não passe longos períodos sem comer.
- Proteína em torno de 100 a 140 g por dia, distribuída ao longo do dia.
- Prato: ½ vegetais, ¼ proteína, ¼ carboidrato integral.
- Reduza bebidas calóricas, ultraprocessados e álcool.
- Treino de força 3 vezes por semana e caminhadas progressivas.
- Tai Chi para equilíbrio, mobilidade e estresse.
- Durma 7 a 9 horas, com horários fixos e sem cafeína à tarde.
- Acompanhe peso, cintura, força e exames; ajuste com a equipe de saúde.

Fontes de referência: Guia Alimentar para a População Brasileira (Ministério da Saúde); Diretrizes de atividade física da OMS (2020); Posicionamento da ISSN sobre proteína e exercício (2017); Consenso da AASM/SRS sobre duração do sono em adultos; Wilding et al., Diabetes Obes Metab, 2022 (extensão do STEP 1).

Registro semanal · Nestor Araujo

Copie esta página (ou imprima várias) e preencha uma por semana. Pese-se e meça o abdômen sempre no mesmo dia e horário.

Semana nº:		Início:		Peso (kg):		Abdômen (cm):		Pressão:		Passos/dia (média):	

Dia	Café da manhã	Lanche manhã	Almoço	Lanche tarde	Jantar	Água (L)	Hora de dormir	Hora de acordar	Treino / caminhada	Fome, humor, sintomas
Seg										
Ter										
Qua										
Qui										
Sex										
Sáb										
Dom										

Observações da semana (proteína batida? remédios e suplementos tomados? ronco, uso do aparelho, sonolência, pressão, humor, o que funcionou e o que ajustar)